

FICHA DE TRATAMIENTO

TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL (TCC)

T C C

La Terapia Cognitivo-Conductual es un enfoque estructurado, colaborativo y orientado al cambio. Modifica patrones de pensamiento y comportamiento que mantienen el malestar psicológico.

1. Proceso terapéutico en TCC

El tratamiento se organiza en fases definidas que permiten una intervención sistemática y guiada por la formulación del caso.

Fase 1: Evaluación inicial

Es el punto de partida del tratamiento. Permite comprender el problema en profundidad y construir una base sólida para la intervención. Se exploran:

- Síntomas actuales y funcionamiento diario
- Situaciones disparadoras
- Historia clínica, personal y social
- Recursos y fortalezas del paciente

Fase 1b: Evaluación de componentes

- Historia clínica: antecedentes médicos, psicológicos, familiares y sociales.
- Evaluación cognitiva: pensamientos automáticos, creencias, distorsiones.
- Evaluación conductual: análisis funcional mediante modelo ABC.
- Evaluación emocional y fisiológica: respuestas corporales y regulación.
- Funcionamiento social: vínculos, apoyos y conflictos.

Fase 2: Integración y Formulación del caso

La información recolectada se integra para construir una hipótesis explicativa del funcionamiento del paciente. La formulación incluye:

- Descripción del problema e historia
- Análisis funcional (ABC)
- Pensamientos automáticos y creencias nucleares
- Conductas problema y evitaciones
- Factores de mantenimiento

Es dinámica y se ajusta a lo largo del proceso terapéutico.

FICHA DE TRATAMIENTO

TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL (TCC)

T C C

Fase 3: Establecimiento de objetivos

Los objetivos se definen de manera colaborativa y deben ser claros, específicos, medibles y realistas.

Ejemplo: "Reducir la frecuencia de pensamientos catastróficos en situaciones sociales y disminuir la evitación asociada."

Fase 4: Intervención

Las estrategias se seleccionan en función de la formulación del caso:

- Cognitivas: reestructuración cognitiva, identificación de distorsiones.
- Conductuales: exposición gradual, activación conductual, experimentos conductuales.
- Emocionales: regulación emocional, manejo de ansiedad.
- Fisiológicas: técnicas de respiración y relajación.

Fase 5: Entrenamiento en habilidades

- Manejo del estrés
- Regulación de ansiedad e ira
- Resolución de problemas
- Comunicación asertiva

El objetivo es aumentar la autonomía del paciente.

Fase 6: Planificación del tratamiento

- 1. Psicoeducación
- 2. Registro de pensamientos automáticos
- 3. Reestructuración cognitiva
- 4. Exposición gradual jerarquizada
- 5. Técnicas de relajación
- 6. Prevención de recaídas

Fase 7: Revisión y evaluación continua

El proceso se monitorea de forma constante: se evalúan avances, se ajustan objetivos y se modifican estrategias si es necesario.

Prevención de recaídas

Consolidar aprendizajes · Identificar señales tempranas de recaída
Diseñar un plan de acción · Fortalecer la autoeficacia del paciente